

NS

MAGALI DA SILVA CAMPOS

IDADE: 58 PESO: 80 ALTURA: 160 PROFISSÃO: Aposentada (desaque) floral

SINTOMAS: Fadiga / sonolência

QUEIXAS: Apaga por 3d seguidos no inverno / cansaço

MEDICAMENTOS: Atenolol / simvastatina / morfina 1x/die

Sonambulismo - Crise convulsiva / Hipert. 2 / HAS / DM

MÉDICO: Dr. Mauro Vinícius (Gabapentina / AAS / Doxepina / 900-1000mg/die) Amitril / Gardinal 200mg

EXERCÍCIO FÍSICO: Fixot.

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: come ALMOÇO: pouco LANCHE: (2x) JANTAR: a noite 50mg manhã 150mg a noite

HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 8h - 9h

COCHILO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: —

TIPO DE RESPIRAÇÃO: mista BANHEIRO: 3 a 4x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: gorda CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV (+) IAH: 58,5 SPO2: 80%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: SpO2 média: 89%

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS

Dor na coluna 2005 - Atrofia de gôd. /

Capulite de ombro (S) / Espondilose cervical

ombro e torácica

05/12 Avaliação

23

15/01 Relata sonambulismo, pesadelos. - Jua

24 há 4 anos, dorme sozinho.

22/01/24 P = 9,5 cmH₂O Perc 95% = 10,7 cmH₂O

IAH = 5,5 elh

m. uso = 7h40' Jato 6 a 14 cmH₂O

fuga = 18 l/min

29/01 P = 11 cmH₂O perc. Relata melhora do qua

24 IAH = 4,9 elh dro de sonolência; fa

m. de uso: 8h diga

Fuga = 3,3 l/min. Jua Odontol

Fixo a pressão 5 min. / max. 11 cmH₂O.

15/02 P = 11 cmH₂O

24 IAH = 5,7 elh

m. de uso: 7h26'

Fuga = 4,7 l/min. Jua

Bem adapt. mas tem pesadelo e

retiro a noite.

03/03/24 $P = 11.6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 6.1$
m. de uso: 6h 10min

fuga: 10.6
bem adaptada / vai para o
neurologista devido aos quadros e
tumor no tumor.

Natacha
agora e/ou sobre virados.

21/06/24 $P = 11.6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 3.2 \text{ e/ev}$
m. de uso: 5h 46'
Fuga = 15.5 lpm.

troco o filtro. Jua Cleáudia

13/09
24 $P = 11.6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 3.2 \text{ e/ev}$
m. de uso: 6h 48'
Fuga = 1.0 lpm

Jua.

22/09/24 $P = 11.6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 2.4 \text{ e/ev}$
m. de uso: 7h 56'

Troco filtro

Natacha

25/10/24 $P = 11.6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 3.6 \text{ e/h}$

m. de uso: 6h 39'
fuga: 0.4 l/m

Bem adaptada

Natacha

Nome: MAGALI DA SILVA CAMPOS

Data de Nascimento: 29-3-1965

IMC: 31,25

Sexo: Feminino

Data do exame: 12-08-2023

Peso: 80 kg

Altura: 1,60 m

Médico: DR. MAURO VINICIUS DOS REIS

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 12-08-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 592,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 103,5 e 143,5 minutos. O tempo total de sono foi de 427,5 min, eficiência de 72,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,7%; estágio N2: 65,8%; estágio N3: 9,1%; sono REM: 22,3%. O índice de despertares foi de 30,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 58,5/hora, sendo 38 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 239 hipopnéias. A SpO2 média foi de 89% e a mínima de 80%, permanecendo 46,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 62 - 84 bpm e NREM de 58 - 83 bpm.

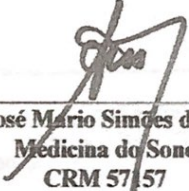
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (09), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 58,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=80%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157